Devenir des nouveau-nés prématurés au Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya

Nagalo K[1]*, Savadogo H[2], Saba SD[3].

[1] UFR SDS UJKZ, Unité de néonatologie, CHUP CDG, Ouagadougou

[2] UFR SDS UBLO, Servie de Pédiatrie CHUR Ouahigouya, Ouahigouya

[3] UFR SDS UBLO, Ouahigouya

PLAN

- ❑ INTRODUCTION ET ENONCE DU PROBLEME
- ❑ OBJECTIFS
- ❑ PATIENTS ET METHODE
- ❑ RESULTATS
- ❑CONCLUSION

INTRODUCTION/ENONCE DU PROBLEME

INTRODUCTION/ENONCE DU PROBLEME (1/4)

- **Prématurité : naissance avant 37 SA ou 259ème jour de gestation**
- **OMS : 15 millions de prématurés chaque année dans le monde**
- **Monde**
  - **1ère cause de mortalité chez les enfants < 5 ans**
  - **1 million de décès chaque année**
- **Problème de santé publique**

INTRODUCTION/ENONCE DU PROBLEME (2/4)

- **Afrique : Une des principales causes de décès néonatal**
- **Afrique : Fréquence hospitalière**
  - **Sénégal 16,5 %**
  - **Tchad 1,4 %**
  - **Centrafr. 28,4 %**
- **BF 2019 : 13 % de décès chez les enfants < 5 ans**

INTRODUCTION/ENONCE DU PROBLEME (3/4)

- Répercussions à court et à long terme ➡ handicaps
- Séquelles de la prématurité ➡ plusieurs années
- Au CHUR-OHG, pas de données disponibles sur le devenir des nouveau-nés prématurés à court et à long terme

But de l'étude : Evaluer le pronostic de la prématurité

OBJECTIFS

OBJECTIFS (1/3)

- **Objectif général**

Etudier le devenir à court et à long terme des nouveau-nés prématurés hospitalisés dans l'unité de néonatologie du CHUR-OHG du 1er janvier au 31 décembre 2021.

OBJECTIFS (2/3)

- **Objectifs spécifiques**

1. Déterminer la fréquence de la prématurité au CHUR-OHG durant la période d'étude
2. Décrire les caractéristiques socio-démographiques et cliniques des nouveau-nés prématurés
3. Déterminer le taux de mortalité des nouveau-nés prématurés

OBJECTIFS (3/3)

- **Objectifs spécifiques**

4 - Evaluer la croissance staturo-pondérale des prématurés à 3 ans

5 - Evaluer le développement psychomoteur de ces enfants à 3 ans

6 - Déterminer les facteurs pronostiques de la prématurité au CHUR-OHG

PATIENTS ET METHODE

PATIENTS ET METHODE (1/5)

- **Cadre étude** : service de pédiatrie, UN du CHUR OHG
- **Type** : étude transversale à visée descriptive et analytique, collecte rétro-prospective des données
- **Période** : 1er janvier au 31 décembre 2021
- **Population** : Nouveau-nés hospitalisés durant la période

PATIENTS ET METHODE (2/5)

- **Critères d'inclusion**
  - Nouveau-né < 37 SA
  - Hospitalisé dans l'UN du CHUR Ouahigouya
  - Du 1er janvier au 31 décembre 2021
- **Critères de non-inclusion**
  - Nouveau-nés malformés
  - Nouveau-nés « arrivés décédés »
- **Echantillon**
  - NN remplissant les critères d'inclusion

PATIENTS ET METHODE (2/5)

❑ Collecte de données

- **Sources :** dossiers patients, CSME, rapports mensuels du service, statistiques CHU
- **Techniques :** revue documentaire, interview, examen du malade
- **Supports :** fiche de collecte standardisée, individuelle, anonymisée

PATIENTS ET METHODE (2/5)

- **Traitement des données collectées**
  - Saisie : micro-ordinateur, logiciel STATA version 2016
  - Analyse
- **Ethique**
  - Autorisations
  - Confidentialité
  - Anonymat
  - Convention de Helsinki

PATIENTS ET METHODE (2/5)

- **Variables** :
  - Caractéristiques sociodémographiques des prématurés
  - Données cliniques prématurés
  - Données évolutives

RESULTATS

RESULTATS (1/14)

Fréquence

- Globale = 30,3 % (398/1 314)
- Mensuelle
  - Août : 19,7 %
  - Mars, Avril, Mai : ≅ 10 %
  - Juin, Juillet : ≅ 4 %

RESULTATS (1/14)

❑ Caractéristiques socio-démographiques

❖ **Sexe**
- M = **51,1 %**
- F = **48,9 %**

Sex-ratio = 1,04

❖ **Age gestationnel**
- < 28 SA = 13 %
- 28-32 SA = **51,1 %**
- 33-36 SA = 35,9 %

RESULTATS (1/14)

- **Caractéristiques cliniques à la naissance**
  - **Poids moyen = 1 438,9 g ± 416 g [500, 2 900]**
  - **Taille moyenne = 40 cm ± 4,2 cm [30, 48 cm]**
  - **Périmètre crânien moyen = 27,9 cm ± 2,9 cm**

RESULTATS (1/14)

❑ Caractéristiques cliniques à la naissance

- **Le poids à la naissance (g)**

[500 – 999] = 12,4 %

[1 000 – 1 499] = 45,1 %

[1 500 – 2 499] = 41,6 %

≥ 2 500 = 0,9 %

RESULTATS (1/14)

❑ Devenir des prématurés à court terme

- ❖ **Mortalité globale = 36,8 % (116/315)**
- ❖ **Sortie normale = 60 % (n = 189)**
- ❖ **SCAM = 2,5 % (n = 8)**
- ❖ **Evacuation = 0,6 % (n = 2)**

RESULTATS (1/14)

- **Devenir des prématurés à court terme**

  - **Mortalité selon le sexe : M = 58,6 % F = 41,4 %**

  - **Mortalité selon l 'âge gestationnel**
    - **< 28 SA = 27,6 %**
    - **28-32 SA = 59,6 %**
    - **33-36 SA = 12,9 %**

RESULTATS (1/14)

❑ Devenir des prématurés à court terme

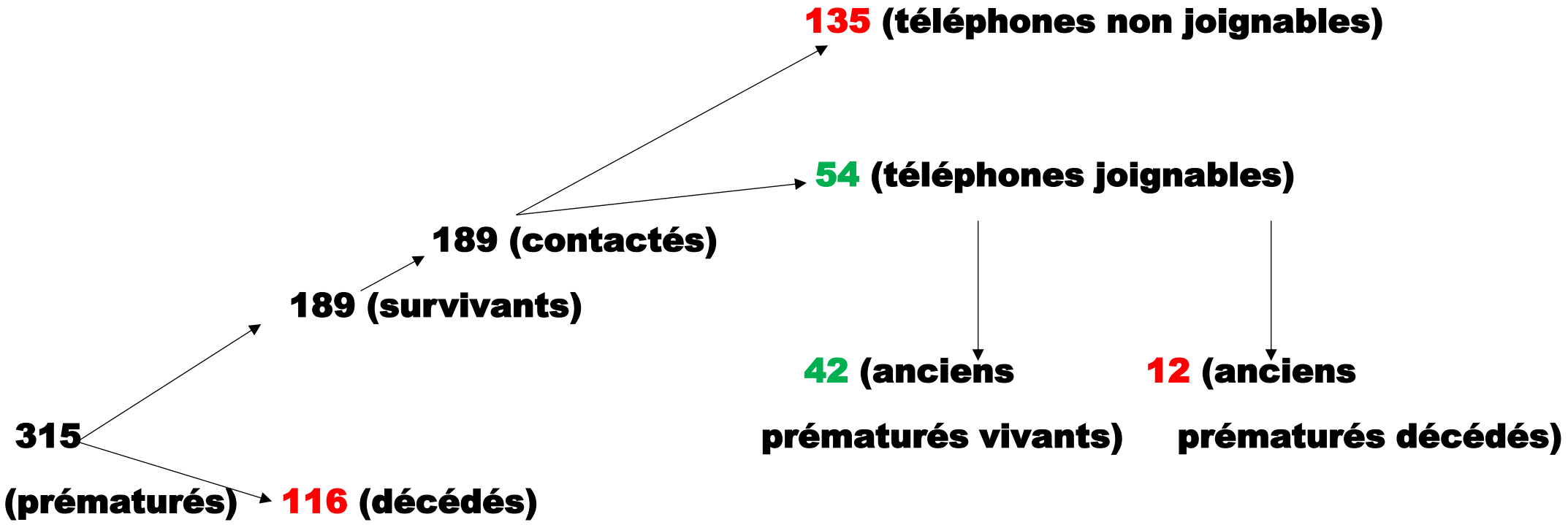
❖ **Mortalité globale = 36,8 %**

❖ **Mortalité selon le poids**

- [500-999 g = 31,8 %
- [1 000-1 499 g] = 55,1 %
- [1 500-2 499 g] = 12,9 %
- ≥ 2 500 g = 0

RESULTATS (1/14)

- **Devenir à 3 ans : Croissance staturo-pondérale et développement psychomoteur**



Revus ■ Perdus de vue ■

Paramètre anthropométrique/âge	Moyenne ± ET	Minimum - maximum
Poids		
6 mois	5,1 ± 0,8	3 - 6,8
12 mois	6,8 ±1	4,7 - 9
2 ans	8,6 ± 1,3	5,5 - 12,3
3 ans	10,6 ± 1,5	8 - 14
Taille		
6 mois	60,3 ± 4,7	50 - 69
12 mois	67,1 ± 5,1	53 - 75
2 ans	77,1 ± 6,1	66 - 91
3 ans	84,6 ± 5,9	73 - 98

PC = 46,4 ± 2,45 cm [40, 52]
PB = 136,1 ± 8,6 mm [110, 160]

RESULTATS (1/14)

❑ Devenir à 3 ans : Croissance staturo-pondérale

- **Indices anthropométriques à 3 ans**

- P/T < à -3 z-score = 2,4 % ⟶ Dénutrition aiguë

- P/A < à -2 z-score = 23,8 % ⟶ insuffisance pondérale

- T/A < à -2 z-score = 54,7 % ⟶ Retard de croissance

RESULTATS (1/14)

❑ **Devenir à moyen terme : Développement psychomoteur à 3 ans**

❖ **Langage**

Langage incorrect = 19,1% (≠ 80,9 % correct)

❖ **Développement neurosensoriel**

- **Vision : pas de troubles visuels**
- **Troubles auditifs = 9,5 %**
- **Déficit moteur = 4,8 % (tétraparésie)**

RESULTATS (1/14)

- **Pathologies développées au cours de l'évolution**
  - **Malnutrition aigue sévère = 23,8 %**
  - **Retards d'acquisitions psychomotrices = 21,4 %**
  - **IRA (bronchites) = 21,4 %**

RESULTATS (1/14)

- **Facteurs de mortalité à court terme (analyse multivariée)**
  - Le sexe masculin ($p = 0,042$)
  - Le poids < 1 500 g ($p = 0,000$)
  - L' AG < 32 SA ($p = 0,000$)

RESULTATS (1/14)

- **Corrélation entre la survenue de retard psychomoteur et données néonatales**
  - Le sexe M ($p = 0,740$)
  - L'âge gestationnel < 32 SA ($p = 0,830$)
  - Le poids < 1 500 g($p = 0,243$)

CONCLUSION

CONCLUSION

- ❑ **Fréquence élevée de la prématurité**
- ❑ **Mortalité élevée en milieu hospitalier pédiatrique**
- ❑ **Morbidité**
- ❑ **Troubles somatiques et psychomoteurs à 3 ans**
- ❑ **Suivi adéquat de ces prématurés**

ICONOGRAPHIE

ICONOGRAPHIE (1/2)

Image 1 : Deux anciennes prématurées jumelles revues en consultation

ICONOGRAPHIE (2/2)

Image 2 : Un ancien prématuré de 3 ans présentant une dénutrition , un retard psychomoteur langagier et moteur (tétraparésie)

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION